Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Página 1/7	
Título do Documento	PROTOCOLO DE SEPSE NO ADULTO	Emissão: 10/08/2026	Próxima revisão: 10/08/2029

PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE SEPSE E CHOQUE SÉPTICO NO ADULTO

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar o reconhecimento precoce, o diagnóstico e o tratamento da sepse e do choque séptico em pacientes adultos no ambiente hospitalar (Pronto-Socorro, Enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva). Este protocolo fundamenta-se nas diretrizes internacionais da *Surviving Sepsis Campaign (SSC) 2026*, adaptadas à realidade brasileira pelo Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), visando a redução da mortalidade e a otimização do uso de recursos institucionais.

2. DEFINIÇÕES (Sepsis-3)

A sepse é definida como uma **disfunção orgânica aguda com risco de vida** decorrente de uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. O **choque séptico** constitui um subgrupo da sepse no qual alterações circulatórias e metabólicas celulares são profundas o suficiente para aumentar substancialmente a mortalidade (hipotensão persistente que requer vasopressores para manter PAM ≥ 65 mmHg e lactato > 2 mmol/L apesar de ressuscitação volêmica adequada).

Atenção: O diagnóstico de sepse é eminentemente **CLÍNICO**. Não deve ser confirmado nem excluído por um único biomarcador ou exame isolado.

3. TRIAGEM E RECONHECIMENTO PRECOCE

A triagem deve ser contínua e sistemática em todos os setores hospitalares. Recomenda-se o uso de escores de alerta precoce sensíveis para identificar pacientes em risco de deterioração clínica.

Ferramentas de Triagem: Utilizar **NEWS, NEWS2, MEWS ou SIRS**. A SSC 2026 emite recomendação **FORTE** contra o uso isolado do qSOFA como ferramenta única de triagem devido à sua baixa sensibilidade. Em uma grande coorte, o NEWS2 apresentou maior sensibilidade do que as demais estratégias

- **Papel do qSOFA:** Útil apenas para sinalizar gravidade e prever mortalidade em pacientes já triados.
- **Papel do SOFA:** Utilizado para caracterizar e quantificar a disfunção orgânica (aumento ≥ 2 pontos em relação ao basal), não como screening inicial.

- **Sinais de Alerta:** Alteração do nível de consciência (Glasgow < 15), hipotensão (PAS < 90 mmHg ou queda > 40 mmHg), taquipneia (FR ≥ 22 irpm), SpO2 < 90%, oligúria, extremidades frias e Tempo de Enchimento Capilar (TEC) > 3 segundos.
- **Resposta Institucional:** Implementação do **"Código Sepse"** ou *sepsis huddle* — acionamento imediato do Time de Resposta Rápida (TRR) ou equipe médica/multidisciplinar organizada para intervenção à beira-leito.

SIRS — o mais sensível, mas pouco específico

O SIRS tem 4 critérios. Se o paciente preencher 2 ou mais, o escore é positivo:

- Temperatura > 38°C ou < 36°C
- Frequência cardíaca > 90 bpm
- Frequência respiratória > 20 irpm ou PaCO2 < 32 mmHg
- Leucócitos > 12.000 ou < 4.000/mm³, ou > 10% de bastões

Como interpretar na suspeita de sepse:

- SIRS negativo → sepse é improvável (bom para "descartar" em adultos jovens/saudáveis).
- SIRS positivo → *não confirma* sepse: pneumonia, trauma, cirurgia, pancreatite e queimaduras também disparam SIRS. É um alerta para investigar infecção, não um diagnóstico.

 No idoso, o SIRS pode falhar: muitos não desenvolvem febre nem leucocitose. Um idoso com SIRS negativo pode sim ter sepse.

ESCALA MEWS – PONTUAÇÃO POR PARÂMETRO

Parâmetro	0 pontos	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Pressão arterial sistólica	101–199	81–100	71–80 ou ≥ 200	≤ 70
Frequência cardíaca	51–100	41–50 ou 101–110	111–129	≤ 40 ou ≥ 130
Frequência respiratória	9–14	15–20	< 9 ou 21–29	≥ 30
Temperatura	35.0–38.4	—	< 35.0 ou ≥ 38.5	—
Consciência (AVPU)	Alerta	Responde à voz	Responde à dor	Inconsciente

ESCALA NEWS2 – PONTUAÇÃO POR PARÂMETRO

Parâmetro	0 pontos	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Frequência respiratória	12–20	9–11 ou 21–24	—	≤ 8 ou ≥ 25
SpO2 (escala 1)	≥ 96%	94–95%	92–93%	≤ 91%
Oxigênio suplementar	Ar ambiente	—	Qualquer O2	—
Pressão arterial sistólica	111–219	101–110	91–100	≤ 90 ou ≥ 220
Frequência cardíaca	51–90	41–50 ou 91–110	111–130	≤ 40 ou ≥ 131
Consciência (AVPU)	Alerta	—	—	Voz, Dor, Inconsciente ou confusão nova
Temperatura	36.1–38.0	35.1–36.0 ou 38.1–39.0	≥ 39.1	≤ 35.0

O NEWS2 é o escore mais recomendado pela SSC 2026. A leitura é por pontuação total e por gatilhos isolados:

Interpretação por pontuação total:

- 0–4 pontos → risco baixo. Manter vigilância de rotina (reavaliar em 4–6h).
- 5–6 pontos → risco médio. Acionar avaliação médica e aumentar frequência de monitorização (reavaliar em 1h).
- ≥ 7 pontos → risco alto. Acionar o médico
- imediatamente e avaliar transferência para UTI.

Gatilhos isolados que exigem ação imediata (mesmo com pontuação baixa):

- 3 pontos em um único parâmetro (ex.: FR ≥ 25 isolado, ou PAS ≤ 90 isolado).
- Confusão mental nova (escore de consciência = 3). Esse é um dos sinais mais fortes de sepse no idoso.

SUSPEITA DE SEPSE NA PRÁTICA:

1. NEWS2 ≥ 5 (ou gatilho isolado) → pare e avalie o paciente agora.
2. Pergunte: *há infecção?* (febre, tosse, disúria, dor abdominal, lesão de pele...).
3. Pergunte: *há disfunção orgânica?* (hipotensão, taquipneia, confusão, oligúria, lactato).

4. Infecção + disfunção orgânica = suspeita de sepse → entre no protocolo (lactato, hemoculturas, antibiótico conforme probabilidade).

ALGUNS PADRÕES COMBINADOS SÃO ALTAMENTE SUGESTIVOS DE SEPSE:

- Taquipneia + taquicardia + hipotensão → tríade clássica de sepse/choque.
- Hipotensão isolada (PAS ≤ 90) em paciente com infecção → choque séptico até prova contrária.
- Confusão mental nova em idoso → sepse é a principal hipótese até descartada (muitas vezes sem febre).
- Temperatura < 36°C (hipotermia) → sepse grave em idoso/imunossuprimido, pior prognóstico que a febre.
- Queda de 2+ pontos no NEWS2 em 1–2 horas → deterioração rápida, típica de sepse.

Diferença prática entre os três: SIRS/NEWS2/MEWS

- SIRS: mais sensível, mas inespecífico. Bom para *não perder* casos em jovens; falha no idoso.
- NEWS2: o mais completo e recomendado pela SSC 2026. Incorpora SpO2, oxigênio suplementar e consciência — capta melhor a deterioração respiratória e neurológica.
- MEWS: mais simples, focado em hipotensão e consciência. Útil em enfermarias com menos recursos, mas menos sensível que o NEWS2.

4. NÍVEIS DE PROBABILIDADE DIAGNÓSTICA (Paradigma SSC 2026)

A abordagem terapêutica deve ser guiada pela probabilidade clínica de infecção, estratificada em quatro níveis:

1. **Sepse DEFINIDA:** Confirmada clinicamente e por exames; diagnóstico alternativo improvável.
2. **Sepse PROVÁVEL:** Alta suspeita clínica; sepse é a hipótese diagnóstica principal.
3. **Sepse POSSÍVEL:** Suspeita moderada; diagnósticos alternativos são igualmente prováveis.
4. **Sepse IMPROVÁVEL:** Baixa suspeita; outras causas não infecciosas justificam o quadro.

5. ABORDAGEM INICIAL (BUNDLE DE RESSUSCITAÇÃO)

Após a identificação do paciente em risco, as seguintes ações devem ser executadas de forma concomitante:

- **Culturas:** Coletar pelo menos 2 pares de hemoculturas (aeróbia e anaeróbia) de sítios distintos. **Não atrasar o antibiótico** se a coleta não puder ser realizada imediatamente.
- **Lactato:** Dosar lactato arterial ou venoso. Se valor inicial > 2 mmol/L, repetir a dosagem em 2 a 4 horas para guiar a ressuscitação.
- **Exames Complementares:** Hemograma, função renal, bilirrubinas, coagulograma e exames de imagem direcionados ao foco suspeito.

6. ANTIBIOTICOTERAPIA

O tempo para a primeira dose de antimicrobiano é o fator determinante de sobrevida mais importante na sepse.

6.1 Metas de Tempo

Cenário Clínico	**Conduta / Prazo**
Sepse **DEFINIDA / PROVÁVEL** ou **CHOQUE**	Antibiótico IMEDIATO (idealmente **< 1 hora**)
Sepse **POSSÍVEL** sem choque	Investigação rápida; iniciar em até **3 horas** se suspeita persistir
Baixa probabilidade sem choque	Adiar antibiótico; manter reavaliação clínica rigorosa

6.2 Otimização e Administração

- **Infusão Prolongada:** Recomendação **FORTE** para o uso de infusão estendida de beta-lactâmicos (ex: Piperacilina-Tazobactam em 3-4h, Carbapenêmicos em 3h) após a dose de ataque em bólus, visando otimizar o tempo acima da MIC.
- **Stewardship:** Reavaliação diária da terapia. Descalonamento conforme culturas e evolução clínica em 24-48h. Duração do tratamento deve ser a mais curta eficaz (geralmente 5 a 7 dias para a maioria dos focos).

6.3 Sugestão de Esquemas Empíricos

Foco Suspeito	**Cenário Comunitário**	**Cenário Hospitalar / Risco MDR**
Pulmonar	Ceftriaxone + Azitromicina	Pip-Tazo ou Cefepime + Claritromicina
Abdominal	Ceftriaxone + Metronidazol	Pip-Tazo ou Meropenem
Urinário	Ceftriaxone ou Ciprofloxacino	Pip-Tazo ou Etapenem/Meropenem
Pele / Partes Moles	Oxacilina ou Cefazolina	Pip-Tazo + Vancomicina (se risco MRSA)
Sem Foco Definido	Ceftriaxone	Pip-Tazo ou Meropenem

7. RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA

- **Volume Inicial:** Administrar **30 mL/kg** de cristaloide nas primeiras 3 horas em pacientes com hipoperfusão ou choque.
- **Ajuste por Peso:** Em pacientes com **IMC > 30 kg/m²**, utilizar o peso ideal ou ajustado para o cálculo.
- **Tipo de Fluido:** Preferir **Cristaloides Balanceados** (Ringer Lactato ou Plasma-Lyte). O Soro Fisiológico 0,9% deve ser evitado em grandes volumes pelo risco de acidose hiperclorêmica, exceto em pacientes com TCE.
- **Monitorização Dinâmica:** Avaliar responsividade a fluidos (elevação passiva das pernas, variação da pressão de pulso) para evitar sobrecarga volêmica.

8. VASOPRESSORES E METAS HEMODINÂMICAS

- **Via de Acesso:** Iniciar vasopressor por **acesso periférico** (veia calibrosa, antecubital) se a hipotensão persistir. Não aguardar acesso central para iniciar a droga.
- **Escolha da Droga: Noradrenalina** é a primeira linha. Se dose > 0,25-0,5 µg/kg/min, associar **Vasopressina**. Se PAM persistir inadequada, associar **Epinefrina**.
- **Metas de PAM:** Adultos em geral: **PAM ≥ 65 mmHg**.
- Idosos (≥ 65 anos): Meta conservadora de **60-65 mmHg** para reduzir arritmias e toxicidade.
- **Guia de Perfusão:** Utilizar o **Tempo de Enchimento Capilar (TEC)** como parâmetro dinâmico à beira-leito.

9. CORTICOIDES E CONTROLE DE FOCO

- **Corticoides:** Indicados no choque séptico refratário (Noradrenalina ≥ 0,25 µg/kg/min por pelo menos 4h). Prescrever **Hidrocortisona 200 mg/dia** (50 mg EV 6/6h).
- **Controle de Foco:** Identificar e intervir no foco anatômico (drenagem de abscesso, desbridamento, remoção de cateter infectado) o mais rápido possível após a estabilização inicial.

10. CRITÉRIOS DE TRANSFERÊNCIA À UTI

Devem ser transferidos prioritariamente pacientes com: necessidade de vasopressores, insuficiência respiratória aguda, lactato persistentemente elevado (> 4 mmol/L), oligúria severa ou rebaixamento do nível de consciência que comprometa a via aérea.

11. CUIDADO PÓS-ALTA

A sepse não termina na alta hospitalar. Deve-se oferecer suporte para a **Síndrome Pós-Sepse**, incluindo reabilitação física, avaliação cognitiva e suporte psicológico, além de revisão de medicações para evitar reinternações.

12. INDICADORES DE QUALIDADE

1. Tempo médio para a 1ª dose de antibiótico (meta < 60 min).
2. Taxa de coleta de hemoculturas pré-antibiótico (meta > 90%).
3. Adesão ao volume de 30 mL/kg em pacientes hipotensos.
4. Taxa de descalonamento de antimicrobianos em 48h.
5. Mortalidade institucional por sepse e choque séptico.

14. REFERÊNCIAS

- *Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026.*
- *Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS) – Protocolos Gerenciados de Sepse 2026.*

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	**DATA**	**DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO**
03	08/08/2026	Elaboração
03	10/08/2026	Aprovação e publicação

Versão 1 – Elaboração **Elaboração** Júlia Regina Chaves Pires Leite Ana Carolina Gomes de Farias **Validação/Revisão** Cláudio Emanuel Gonçalves Filho Matheus Soares Júlia Regina Chaves Pires Leite **Aprovação** Matheus Soares Nilson Lima Sônia da Silva Delgado	Data: 10/08/2026